

Cómo habla tu farmacia

Los cinco estilos del mostrador y los tres
acuerdos que igualan a tu equipo

farmapro®

Que suene igual **quien sea que atienda.**

Acompaña la Edición #27 de farmapro Impulso. No es un guion: es un acuerdo. Lo que se fija aquí es la estructura (qué se pregunta antes de recomendar, con qué nivel de rigor se nombra lo que se recomienda y cómo se dice que no), nunca la frase literal, que cada persona debe decir con sus palabras. Donde veas una línea en blanco va lo que es vuestro. **No lo redactes tú solo:** un acuerdo que llega ya escrito no lo defiende nadie. La página 09 trae el guion de la sesión para construirlo con el equipo en una hora.

00	Los cinco estilos	03
	Quién habla hoy en tu mostrador, y qué aporta cada uno	
01	El orden	04
	Lo que separa el consejo profesional de la venta	
02	Acuerdo 1 · La pregunta previa	05
	Las doce consultas más frecuentes (primera parte)	
03	Acuerdo 1 · La pregunta previa	06
	Las doce consultas más frecuentes (segunda parte)	
04	Acuerdo 2 · El registro	07
	Qué se afirma, qué se matiza y qué no se promete nunca	
05	Acuerdo 3 · El no	08
	Las cuatro negativas del mostrador, resueltas	
06	La sesión de una hora	09
	Guion minutado para dirigirla tú mismo	
07	Vuestros tres acuerdos	10
	La plantilla en blanco, para imprimir y rellenar	
08	Quemose el rollo	11
	La revisión trimestral en quince minutos	

En tu mostrador conviven **cinco** formas de hablar.

Ninguno de los cinco es el bueno y ninguno es el malo. Una farmacia que solo tuviera técnicos sería impecable y fría; una que solo tuviera cercanos sería querida y poco rigurosa. El objetivo no es elegir un estilo: es que los cinco compartan la misma estructura por debajo.

EL ESTILO	QUÉ APORTA Y DÓNDE FALLA
El técnico	Domina el producto y lo explica con precisión. Da seguridad al paciente informado y abruma al que solo quería saber si puede tomarlo con lo suyo. Le sobra información y le falta jerarquía: no siempre distingue lo que hay que decir de lo que se puede decir.
El resolutivo	Despacha rápido y bien. Es quien sostiene la farmacia en las horas punta. Su riesgo es saltarse la pregunta previa cuando hay cola, que es justo cuando más se nota la diferencia entre dispensar y aconsejar.
El cercano	Conoce a las personas y ellas vuelven por él. Genera la confianza que ningún protocolo compra. Su riesgo es el contrario del técnico: a veces la conversación tapa el criterio, y se recomienda por costumbre compartida más que por indicación.
El prudente	No afirma nada que no pueda sostener. Es el que mejor protege a la farmacia. Su riesgo es la parálisis: de tanto matizar, el paciente sale sin una pauta clara y busca la respuesta en otro sitio.
El silencioso	Contesta lo que se le pregunta y nada más. Casi siempre es alguien nuevo, o alguien que no tiene claro hasta dónde puede llegar. No es un rasgo de carácter: es falta de acuerdo. Es el estilo que esta guía resuelve más rápido.

El ejercicio previo. Antes de leer más, pon el nombre de cada persona de tu equipo al lado de un estilo. Incluido el tuyo. Si dudas entre dos, escribe los dos. Esa lista es el punto de partida de la sesión de la página 09.

Suena a venta cuando llega **antes de la pregunta.**

Es la incomodidad más repetida en las farmacias: «si lo recomiendo mucho, parece que vendo». La reacción habitual es recomendar menos, y esa es la salida cara: una farmacia que recomienda poco no es más ética, es más callada, y el paciente que necesitaba una pauta se va sin ella.

MISMA RECOMENDACIÓN	CÓMO LA RECIBE EL PACIENTE
Producto primero «Para eso llévase esto, que va muy bien.»	Suena a venta, aunque el producto sea el correcto y quien lo dice tenga treinta años de mostrador. No hay nada que demuestre que la recomendación es para él y no para cualquiera.
Pregunta primero «¿Desde cuándo le pasa? ¿Está tomando algo más? ¿Le había ocurrido antes?»	Suena a criterio profesional. Las tres preguntas hacen visible que la recomendación se ha construido con lo que él acaba de contar. El producto puede ser exactamente el mismo.

El paciente no evalúa la intención, que no puede ver. Evalúa la secuencia, que sí ve. Por eso el lenguaje común no se construye buscando mejores palabras, sino acordando qué va antes de qué.

OJO Lo que no arregla el orden

Preguntar por preguntar es peor que no preguntar: si la respuesta del paciente no cambia lo que se le va a recomendar, la pregunta se nota impostada y el efecto se invierte. La regla para elegir las preguntas de la página siguiente es exactamente esa: solo entra en la lista la pregunta cuya respuesta puede cambiar la recomendación.

Las doce consultas **que más se repiten.**

Estas son las preguntas previas que proponemos, dos o tres por situación. No son un cuestionario: son el mínimo que cualquiera del equipo puede hacer sin sentirse un interrogador. Táchalas, cámbialas y sobre todo añade las vuestras en la columna en blanco de la plantilla final.

LA CONSULTA	LO QUE SE PREGUNTA ANTES DE RECOMENDAR
Molestias digestivas leves	¿Desde cuándo le ocurre? · ¿Ha cambiado algo en la alimentación o la medicación estos días? · ¿Le había pasado otras veces?
Está tomando antibiótico	¿Se lo han pautado hace mucho? · ¿Le han indicado algo para acompañarlo? · ¿Lo ha tomado otras veces?
Dolor de garganta	¿Desde cuándo? · ¿Tiene fiebre o solo molestia al tragar? · ¿Está tomando algo ya?
Producto para dormir	¿Es algo de estos días o le viene de largo? · ¿Le cuesta coger el sueño o se despierta? · ¿Toma alguna otra medicación?
Dermocosmética, piel sensible	¿Qué usa ahora mismo? · ¿Ha cambiado de producto hace poco? · ¿Le ocurre todo el año o por temporadas?
La novedad vista en televisión	¿Para qué le han dicho que va bien? · ¿Se lo ha recomendado alguien del centro de salud? · ¿Está tomando ya algo parecido?

Las doce consultas (segunda parte).

LA CONSULTA	LO QUE SE PREGUNTA ANTES DE RECOMENDAR
Primera dispensación de un crónico	¿Es la primera vez que lo toma? · ¿Le han explicado cómo y cuándo tomarlo? · ¿Toma alguna otra cosa a diario?
Duda con el genérico	¿Es el cambio lo que le preocupa o cómo le sentó? · ¿Cuál venía tomando? · ¿Se lo ha comentado a quien se lo receta?
Producto infantil	¿Qué edad tiene? · ¿Cuánto pesa aproximadamente? · ¿Está tomando algo más ahora mismo?
Quiere dejar de fumar	¿Ha intentado dejarlo antes? · ¿Qué le funcionó y qué no? · ¿Cuántos cigarrillos al día lleva ahora?
Vitaminas y cansancio	¿Desde cuándo se nota así? · ¿Lo ha comentado en su centro de salud? · ¿Toma ya algún suplemento?
Vuelve porque no le ha funcionado	¿Cuántos días lo ha usado? · ¿Lo ha tomado como se lo explicamos? · ¿Ha notado algo distinto, aunque sea poco?

La última de la lista es la más rentable de todas. Cuando alguien vuelve diciendo que no le ha funcionado, la respuesta por defecto suele ser cambiar de producto. Las tres preguntas de arriba distinguen el producto equivocado del producto bien elegido y mal usado, que es lo más frecuente.

Qué se afirma, qué se matiza y qué no se promete.

Si una persona del equipo dice «esto le va a ir muy bien» y otra dice «esto está indicado para lo que me cuenta», el paciente percibe dos niveles de rigor distintos dentro del mismo establecimiento. Lo que se acuerda no son las palabras: es el nivel.

NIVEL	CUÁNDO SE USA Y CÓMO SUENA
Se afirma	Lo que está en la ficha del producto y en su indicación: para qué está indicado, cómo se toma, cuánto tiempo, con qué no conviene combinarlo. Aquí se habla con seguridad, porque es información contrastable.
Se matiza	Todo lo que dependa de la persona concreta: cuánto tardará en notarlo, si le sentará mejor o peor, si en su caso será suficiente. Se dice en condicional y se acompaña de qué hacer si no ocurre.
No se promete nunca	Resultados de salud concretos, plazos de curación, equivalencias con un tratamiento prescrito, ni nada que invite a sustituir una consulta médica. No es una cuestión de estilo: es el marco deontológico, y conviene que esté escrito y no solo sobrentendido.

LA FRASE PUENTE

Cuando hay que derivar

Acordad también cómo se deriva, que es el momento en el que más se nota la diferencia de registro dentro de un equipo. Una estructura que funciona: se reconoce lo que trae («entiendo lo que me cuenta»), se dice con naturalidad dónde está el límite («esto ya no lo puedo valorar yo desde aquí») y se cierra con una acción concreta («coméntelo en su centro de salud y, cuando le digan algo, vuelve y lo miramos»). Sin disculpa y sin dramatismo.

Las cuatro negativas **del mostrador.**

Este es el acuerdo que más desigual a un equipo y el que casi ninguna farmacia tiene por escrito. Quien lleva años resuelve un no en una frase y el paciente se va satisfecho sin llevarse nada. Quien lleva poco se disculpa, se alarga y a veces acaba dispensando algo para no dejar el mostrador en silencio.

LA SITUACIÓN	LA ESTRUCTURA DE LA RESPUESTA (NO LA FRASE LITERAL)
No lo tenemos	Se dice sin rodeos, se da un plazo real si se puede pedir, y se ofrece la alternativa solo si es equivalente. Si no lo es, se dice que no lo es. Prometer para hoy lo que llega el jueves cuesta más que el no.
Eso necesita receta	Se explica que no es una decisión de la farmacia, sin tono de norma ni de disculpa, y se cierra con la vía concreta para conseguirlo. El paciente tiene que salir sabiendo qué hacer, no sintiéndose rechazado.
Para lo que me cuenta, esto no es lo indicado	Se reconoce primero lo que trae (a menudo viene con un producto ya decidido), se explica en una línea por qué en su caso no encaja, y se propone qué sí. Es el no que más confianza construye cuando se hace bien.
Sobre eso no le puedo aconsejar	El límite de la competencia profesional. Se dice con naturalidad y se deriva con la frase puente de la página anterior. Alargarse aquí es lo que empuja a improvisar.

La regla del silencio. Un no bien dicho deja un silencio de dos segundos y ese silencio es el que más incomoda a quien tiene poca experiencia. Acordadlo también: después del no va la acción concreta, y ahí se acaba. No hace falta rellenar.

Guion minutado para dirigirla tú.

Una hora, con el equipo entero si se puede, y con la farmacia cerrada o en el hueco más tranquilo de la semana. El objetivo no es salir con un documento perfecto: es salir con un acuerdo que todos han ayudado a escribir.

MINUTOS	QUÉ SE HACE
0 a 10	El ejercicio de la distancia. Cada persona escribe, sin hablar con las demás, qué contesta ante las tres consultas más frecuentes de vuestra farmacia. Se leen en voz alta una detrás de otra.
10 a 15	Se nombra lo que ha salido, sin señalar a nadie. La frase que abre bien esta parte: «ninguna está mal, y aun así el paciente ha oído cuatro cosas distintas».
15 a 35	Acuerdo 1. Se eligen las consultas de la lista y se fijan sus preguntas previas. Se descarta toda pregunta cuya respuesta no cambie la recomendación.
35 a 45	Acuerdo 2. Se repasan los tres niveles y se busca un ejemplo real reciente de cada uno. Cinco minutos bastan si hay ejemplos; sin ejemplos no se entiende.
45 a 55	Acuerdo 3. Las cuatro negativas, en voz alta, cada persona con sus palabras. Esta es la parte que más incomoda y la que más se agradece a los tres meses.
55 a 60	Se fija la fecha de la primera revisión y quién la convoca. Sin fecha, el acuerdo dura lo que dura el papel encima del mostrador.

EVITAD ESTO

Las tres formas de estropear la sesión

Llevarlo ya redactado y pedir opinión (nadie defiende lo que no ha escrito) · Usar el ejercicio de la distancia para corregir a alguien delante del resto (es la manera más rápida de que la siguiente sesión no venga nadie) · Intentar cerrar los tres acuerdos y las doce consultas el mismo día (con cuatro consultas bien acordadas ya se nota el cambio).

La plantilla **en blanco**.

Imprimid esta hoja y rellenadla durante la sesión. Una copia en el mostrador y otra donde se incorpora a las personas nuevas.

ACUERDO 1 · LO QUE PREGUNTAMOS ANTES DE RECOMENDAR

NUESTRAS CONSULTAS FRECUENTES

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Consulta: _____ | Preguntas: _____ |
| 2. Consulta: _____ | Preguntas: _____ |
| 3. Consulta: _____ | Preguntas: _____ |
| 4. Consulta: _____ | Preguntas: _____ |
| 5. Consulta: _____ | Preguntas: _____ |
| 6. Consulta: _____ | Preguntas: _____ |

ACUERDO 2 · NUESTRO REGISTRO

UN EJEMPLO REAL DE CADA NIVEL

Afirmamos: _____
 Matizamos: _____
 No prometemos nunca: _____
 Cómo derivamos: _____

ACUERDO 3 · CÓMO DECIMOS QUE NO

CON VUESTRAS PALABRAS

No lo tenemos: _____
 Necesita receta: _____
 No es lo indicado para su caso: _____
 No puedo aconsejarle sobre eso: _____

Fecha del
acuerdo _____

Personas que lo
han escrito _____

Fecha de la
primera revisión _____

Quién la convoca _____

Quince minutos **cada trimestre.**

Un acuerdo de lenguaje no se rompe: se desgasta. Nadie decide dejar de aplicarlo, simplemente entran consultas nuevas, entra gente nueva y el papel se queda hablando de una farmacia que ya no es exactamente esta. La revisión existe para eso y no necesita más de quince minutos.

SE PREGUNTA	QUÉ SE HACE CON LA RESPUESTA
¿Qué consulta nueva ha aparecido este trimestre?	Si se repite lo suficiente como para que alguien la recuerde, entra en el acuerdo 1 con sus preguntas previas.
¿Qué pregunta previa no está usando nadie?	Se quita. Si nadie la hace es que no cambia la recomendación, y mantenerla en el papel resta credibilidad al resto.
¿Qué no nos ha salido bien decir?	Se reescribe entre todos ahí mismo. Casi siempre es una de las cuatro negativas.
¿Ha entrado alguien nuevo?	Se le da la hoja y se hacen diez minutos de práctica en voz alta. Es la vía más rápida para que deje de ser el estilo silencioso.

La señal de que está funcionando no es que todos digan lo mismo, porque eso no va a pasar y tampoco sería bueno. Es que un paciente atendido por dos personas distintas reciba las mismas preguntas y el mismo nivel de rigor, aunque las palabras cambien.

farmapro

Sobre farmapro:

farmapro es el ecosistema digital de referencia para farmacias en España. En los últimos 15 años hemos ayudado a más de 500 titulares a impulsar su farmacia, ordenar su gestión y hacer crecer su equipo.

Si quieres que acompañemos esa sesión con tu equipo,
escribenos:

somos@farmapro.es

© *farmapro impulso* | Todos los derechos reservados

605 87 57 01 | **somos@farmapro.es**
farmapro.es | **@farmapro.official**